SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 1061/I-SP/DIR/VIII/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Lengkap & Gelar : Nurul Ermawati, A.Md.Farm
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 23 Januari 1991
Tanggal Awal Masuk : 01 Oktober 2023
Jabatan : TTK Pelaksana

Dengan ini menyatakan bahwa **SAYA TIDAK AKAN MENGULANGI KELALAIAN KESALAHAN IDENTIFIKASI OBAT.**

Saya menerima konsekuensi atas kelalaian saya, yaitu mendapatkan SP ke 1 dengan ketentuan potong gaji 5% dari total gaji bersih selama 6 bulan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di RS Prima Husada Malang.
Saya berjanji saya akan bekerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah disepakati.

Jika dikemudian hari saya melakukan kesalahan yang sama, maka saya bersedia dikenakan **SANKSI LANJUTAN SESUAI ATURAN YANG BERLAKU DI RS PRIMA HUSADA MALANG**.

Malang, 09 Agustus 2024

Yang Menyatakan,	Mengetahui			
	Kepala Ruang	Kepala Bidang Penunjang Medis	SDM RS Prima Husada	PLT Direktur RS Prima Husada
materai				RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
Nurul Ermawati, A.Md.Farm	**Apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm**	**Putri Indah Purnamasari, A.Md.Keb**	**Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi**	**dr. Nur Mazidah**

SURAT PERINGATAN 1

NOMOR : 1061/I-SP/DIR/VIII/2024

Surat Peringatan diberikan kepada :

No	Nama Staf	Unit	Keterangan Pelanggaran
1	Nurul Ermawati, A.Md.Farm	Farmasi	1. Melakukan pekerjaan atau perbuatan yang dapat merugikan nama baik Perusahaan. 2. Tidak patuh pada instruksi / prosedur / petunjuk kerja yang berlaku.

Sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan saat ini :
□ Teguran Lisan
□ Teguran Tertulis
√ **SP-1**
□ SP-2
□ SP-3
Sanksi berupa : Pemotongan upah sebesar 5% dari total gaji diluar potongan selama 6 bulan.

Malang, 09 Agustus 2024

Disetujui,
Karyawan yang bersangkutan,

Nurul Ermawati, A.Md.Farm

Diketahui,
SDM

Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi

Mengetahui

PLT Kepala Bidang Penunjang Medis

Putri Indah Purnamasari, A.Md.Keb

PLT Direktur RS Prima Husada Malang

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

dr. Nur Mazidah

Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS

NO. IKP : 1061/I-SP/DIR/VIII/2024

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

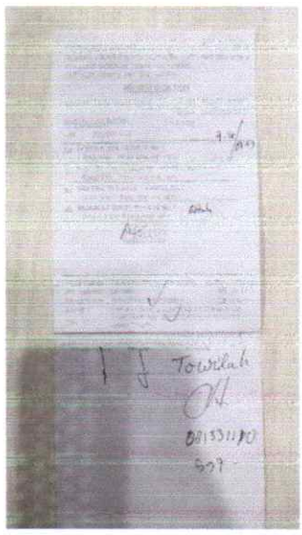
LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

I. DATA PASIEN

Nama : Prawira Tri Yudha Sampurno
No. RM : 137243
Ruangan : Bougenvile
Umur * : □ 0-1 bulan □ > 1 bulan – 1 tahun
√ > 1 tahun – 5 tahun □ > 5 tahun – 15 tahun
□ > 15 tahun – 30 tahun □ > 30 tahun – 65 tahun
□ > 65 tahun
Jenis kelamin : √ Laki-laki □ Perempuan
Penanggung biaya pasien : □ Pribadi □ Asuransi Swasta
√ BPJS □ Lainnya (umum)
Tanggal Masuk Ruangan : 22/07/2024

II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden :

TANGGAL/ JAM	KRONOLOGI	KETERANGAN (bisa diisi foto/ bukti-bukti)
24/07/2024 pukul 08.35	Keluarga Pasien datang ke depo farmasi dengan membawa surat kontrol, lalu keluarga pasien menyerahkan surat kontrol tersebut dan meninggalkannya ke petugas primantara. Petugas primantara memberitahukan kepada TTK irna bahwa ada keluarga pasien mengambil obat pulang. Nurul mengambil surat kontrol tersebut dan memanggil nama sesuai dengan nama yang tertera di surat kontrol. Keluarga Pasien datang dan Nurul menanyakan kembali apakah benar nama keluarga pasien sesuai dengan yang tertera di surat kontrol tersebut pasien yang bernama ibu towilah menjawab iya. Kesalahan Nurul tidak mengidentifikasi kembali data pasien bahwa ibu towilah tersebut bukan keluarga pasien yang bersangkutan dan Obat langsung diserahkan ke pasien.	

24/07/2024 Pukul 09.35	Keluarga pasien Prawira Tri Yudha Sampurno nama yang tersebut disurat kontrol menanyakan kembali perihal obat pulangnya dan baru diketahui apabila obat pulang yang diserahkan TTK salah penerima. Dan ternyata yang menerima obat tersebut ibu Towillah dari pasien rawat jalan (008944) dari poli dr .Miryanti, Sp.JP. Nurul menghubungi ibu towillah untuk konfirmasi obat yang didapatkan an prawira dan ternyata benar menerima obat an prawira. Kemudian nurul KIE ke pasien ada kesalahan pemberian obat. Sehingga nurul menawarkan obat pasien diantarkan ke rumah dan mengambil obat yang salah.	
24/07/2024 Pukul 12.45	Keluarga pasien bu towillah datang ke depo farmasi untuk mengambil obat yang benar dan mengembalikan obat prawira.	

Simpulan : Kesalahan pemberian obat

Jenis Insiden* :
☐ Kejadian Potensial Cedera / KPC
☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
√ Kejadian Tidak Cedera / KTC
☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)

2. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
☐ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
☐ Pasien
√ Keluarga / Pendamping pasien

☐ Pengunjung
☐ Lain-lain .....**(sebutkan)**

3. Insiden terjadi pada* :
   √ Pasien
   ☐ Lain-lain .....**(sebutkan)**
   Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.

4. Insiden menyangkut pasien :
   √ Pasien rawat inap
   ☐ Pasien rawat jalan
   ☐ Pasien UGD
   ☐ Lain-lain .....**(sebutkan)**

5. Tempat Insiden
   Instalasi Farmasi

6. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
   ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
   √ Anak dan Subspesialisasinya
   ☐ Bedah dan Subspesialisasinya
   ☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
   ☐ THT dan Subspesialisasinya
   ☐ Mata dan Subspesialisasinya
   ☐ Saraf dan Subspesialisasinya
   ☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
   ☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
   ☐ Jantung dan Subspesialisasinya
   ☐ Paru dan Subspesialisasinya
   ☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
   ☐ Lain-lain Urologi

7. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden
   Instalasi Farmasi

8. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
   ☐ Kematian
   ☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
   ☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
   √ Cedera Ringan
   ☐ Tidak ada cedera

9. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
   segera konfirmasi kepada keluarga pasien Prawira terkait kesalahan pemberian obat dan menghubungi pasien ibu Towillah dari rawat jalan yang menerima obat agar tidak mengkonsumsi obat yang diterima dan menukar kembali obat yang salah terima tersebut dengan obat yang benar.

10. Tindakan dilakukan oleh* :
    √ Tim, terdiri dari : TTK
    ☐ Dokter
    ☐ Perawat
    ☐ Petugas lainnya
    .....

11. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*
□ Ya √ Tidak
Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.
Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?

Pembuat Laporan	: Nurul Ermawati	Penerima Laporan	: .....
Paraf	:	Paraf	: .....
Tgl Lapor	: 26/07/2024	Tgl terima	: .....

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :
√ **BIRU** □ **HIJAU** □ **KUNING**
□ **MERAH**
NB. * = pilih satu jawaban

III. TIPE INSIDEN

No.	Tipe Insiden		Subtipe Insiden
1.	Administrasi Klinik	a. Proses	1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (*Transfer of care*) 8. Identifikasi pasien 9. *Consent* 10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan
		b. Masalah	1. Tidak *performed* ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pelayanan
2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining/ pencegahan/ *medical check up* 2. Diagnosis/ *assessment* 3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. *General care/ management* 5. Tes/ investigasi 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (*detention/ restraint*)
		b. Masalah	1. Tidak *performance* ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. *Chart*/ rekam medik/ *assessment*/ konsultasi 3. *Checklist* 4. Form/ sertifikat

			5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ *Guideline* 6. Label/ stiker/ identifikasi *bands*/ kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ *images*
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen 3. Salah dokumen/ salah orang 4. Tidak jelas/ membingungkan/ *illegible*
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	1. Bakteri 2. Virus 3. Jamur 4. Parasit 5. Protozoa 6. Rickettsia 7. Prion/ partikel protein yang infeksius 8. Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	1. *Bloodstream* 2. Bagian yang dioperasi 3. Abses 4. Pneumonia 5. Kanul IV 6. Protesis infeksi 7. Drain/ tube urin 8. Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	1. Daftar Medikasi 2. Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Ciaran infus	1. Peresepan 2. Persiapan/ *dispensing* 3. Pemaketan 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. *Supply*/ pesan 7. Penyimpanan 8. Monitoring
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah obat
			1. Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi 2. Salah formulasi/ presentasi 3. Salah rute pemberian 4. Salah jumlah/ kuantitas 5. Salah *Dispensing* Label/ instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. *Ommited medicine or dose* 9. Obat kadaluarsa 10. Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Produk selular 2. Faktor pembekuan (*clothing*) 3. Albumin/ plasma protein 4. Imunoglobulin
		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Tes pre transfusi 2. Peresepan 3. Persiapan/ *dispensing* 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. Penyimpanan 7. Monitoring 8. Presentasi/ pemaketan

			9. *Supply*/ pesan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah darah/ produk darah 3. Salah dosis/ frekuensi 4. Salah jumlah 5. Salah label *dispensing*/ Instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. Obat atau dosis yang diabaikan 9. Darah kadaluarsa 10. Efek samping/ *adverse effect*
7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	1. Nutrisi umum 2. Nutrisi khusus
		b. Proses nutrisi	1. Peresepan/ permintaan 2. Pesiapan/ manufaktur/ memasak 3. *Supply*/ pesan 4. Penyajian 5. *Dispensing*/ alokasi 6. Pengantaran 7. Pemberian 8. Penyimpanan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah diet 3. Salah jumlah 4. Salah frekuensi 5. Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait
		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	1. Label silinder/ warna kode/ *index pin* 2. Peresepan 3. Pemberian 4. Pengantaran 5. Supply/ order
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah gas 3. Salah *rate*/ *flow*/ konsentrasi 4. Salah mode pengantaran 5. Kontraindikasi 6. Salah penyimpanan 7. Gagal pemberian 8. Kontaminasi
9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ *Equipment property*	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ *Equipment property*	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ *equipment property*
		b. Masalah	1. Presentasi/ pemaketan tidak baik 2. Ketidaktersediaan 3. *Inapropiate for task* 4. Tidak bersih/ tidak steril 5. Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien	1. Tidak kooperatif 2. Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar 3. Berisiko/ sembrono/ berbahaya 4. Masalah dengan penggunaan substansi/ *abuse* 5. Menggangu/ *harrassment* 6. Diskriminasitif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederai diri, bunuh diri.
		b. Agresi /	1. Agresi verbal

		Assault	2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh	1. Tersandung 2. Slip 3. Kolaps 4. Hilang keseimbangan
		b. Keterlibatan saat jatuh	1. *Velbed* 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet 6. Peralatan terapi 7. Tangga 8. Dibawa/dibantu oleh orang lain
12.	Kecelakaan	a.Benturan tumpul	1. Kontak dengan benda/binatang 2. Kontak dengan orang 3. Hancur, remuk
		b. Serangan tajam/ tusukan	Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan
		c. Kejadian mekanik lain	1. Benturan akibat ledakan bom 2. Kontak dengan mesin
		d. Peristiwa mekanik lain	
		e. Mekanisme Panas	Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan
		f. Ancaman pada pernafasan	Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ *confinement to oxygen-deficient place*
		g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya	1. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 2. Bahan kimia korosif
		h. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera	1. Paparan listrik/radiasi 2. Paparan suara/ getaran 3. Paparan tekanan udara 4. Paparan karena gravitasi rendah
		i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	1. Daftar struktur 2. Daftar bangunan 3. Daftar *furniture* 4. Inadekuat 5. Damaged/ faulty/ worn

14.	*Resource/* Manajemen organisasi	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan Sumber Daya Manusia Ketersediaan/ keadekuatan staf Organisasi/ Tim b. *Protocols/* Kebijakan/ SOP Guideline c. Ketersediaan/ *Adequacy*	
15	Laboratorium/ Patologi	Pengambilan/ *pick up transport sorting* data *entry* proses verifikasi/ validasi hasil	

1. Penyebab langsung (Direct / Proximate / Immediate Cause)
   Tidak melakukan identifikasi pasein dan double check dalam proses penyerahan ke pasien.

2. Akar penyebab masalah (underlying - root cause)
   Petugas farmasi Tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar sehingga menyebabkan kesalahan pemberian obat

3. Rekomendasi / Solusi

NO	AKAR MASALAH	REKOMENDASI/ SOLUSI
1	Ketidak telitian petugas	Melakukan identifikasi pasien lebih teliti lagi sebelum diserahkan kepada pasien, memastikan lagi yang mengambil obat tersebut adalah keluarga pasien dengan cara menyanyakan status hubungan dengan pasien. Meningkatkan kedisiplinan dan ketelitian saat penyerahan obat
2		

NB.* : Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain
Saran : Baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselaman Pasien

Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS

NO. IKP : 1061/I-SP/DIR/VIII/2024

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

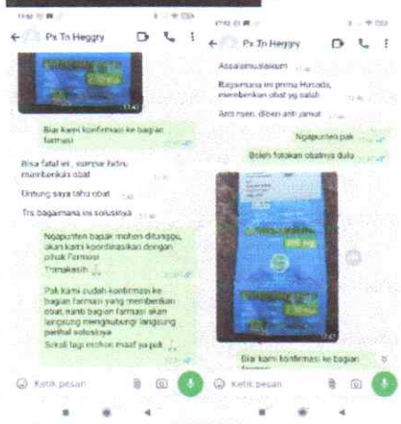
IV. DATA PASIEN

Nama : Henggry Hermawan
No. RM : 217522
Ruangan : Anggrek
Umur * : ☐ 0-1 bulan ☐ > 1 bulan – 1 tahun
☐ > 1 tahun – 5 tahun ☐ > 5 tahun – 15 tahun
☐ > 15 tahun – 30 tahun √ > 30 tahun – 65 tahun
☐ > 65 tahun
Jenis kelamin : √ Laki-laki ☐ Perempuan
Penanggung biaya pasien : ☐ Pribadi √ Asuransi Swasta
☐ BPJS ☐ Lainnya (umum)
Tanggal Masuk Ruangan : 28/7/2024

V. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden :

TANGGAL/ JAM	KRONOLOGI	KETERANGAN (bisa diisi foto/ bukti-bukti)
02/08/2024 Pukul 07.13	Obat RF diresepkan pagi oleh perawat 2C yaitu furosemide tab, asam tranexamat tab, tamsulosin tab, ketoprofen tab, bd micro, cefadroxile caps. Lili memproses resep dan melakukan pengakajian resep. Lili cetak resep dan etiket kemudian disiapkan oleh Lilis serta menempelkan etiket. Obat selesai disiapkan pukul 08.10. Farmasi telpon 2C konfirmasi bahwa obat sudah selesai.	
02/08/2024 Pukul 14.47	Siangnya pasien datang ke depo farmasi untuk mengambil obat pulang dan di KIE oleh Nurul dengan resep obat nyeri ketoprofen tablet sebanyak 10 tablet dan obat langsung diserahkan kepada pasien tanpa double crosscheck.	

02/08/2024 Pukul 17.25	Pasien komplain ke ruangan IRNA 2C bahwa obat yang diterima tidak sesuai dengan resep yaitu ketoprofen tab diberikan ketoconazole tab, barulah diketahui bahwa obat tidak sesuai. Farmasi langsung menyiapkan obat yang benar sesuai resep dan obatnya dikirim oleh primantara.	

Simpulan : Kesalahan pemberian obat

Jenis Insiden* :
- ☐ Kejadian Potensial Cedera / KPC
- ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
- √ Kejadian Tidak Cedera / KTC
- ☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
- ☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)

12. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
    - ☐ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
    - √ Pasien
    - ☐ Keluarga / Pendamping pasien
    - ☐ Pengunjung
    - ☐ Lain-lain .....**(sebutkan)**

13. Insiden terjadi pada* :
    - √ Pasien
    - ☐ Lain-lain .....**(sebutkan)**

    Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.

14. Insiden menyangkut pasien :
    √ Pasien rawat inap
    □ Pasien rawat jalan
    □ Pasien UGD
    □ Lain-lain .....**(sebutkan)**

15. Tempat Insiden
    Instalasi Farmasi

16. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
    √ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
    □ Anak dan Subspesialisasinya
    □ Bedah dan Subspesialisasinya
    □ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
    □ THT dan Subspesialisasinya
    □ Mata dan Subspesialisasinya
    □ Saraf dan Subspesialisasinya
    □ Anastesi dan Subspesialisasinya
    □ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
    □ Jantung dan Subspesialisasinya
    □ Paru dan Subspesialisasinya
    □ Jiwa dan Subspesialisasinya
    □ Lain-lain Urologi

17. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden
    Instalasi Farmasi

18. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
    □ Kematian
    □ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
    □ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
    □ Cedera Ringan
    √ Tidak ada cedera

19. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
    TTK segera menghubungi pasien untuk konfirmasi dan segera mengganti dengan obat yang benar

20. Tindakan dilakukan oleh* :
    √ Tim, terdiri dari : TTK
    □ Dokter
    □ Perawat
    □ Petugas lainnya
    .....

21. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*
    √ Ya □ Tidak
    Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.
    Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?

Pembuat Laporan	: Nurul Ermawati	Penerima Laporan	: .....
Paraf	:	Paraf	: .....

Tgl Lapor	: 02 Agustus 2024	Tgl terima	: .....

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :
☐ **BIRU** √ **HIJAU** ☐ **KUNING**
☐ **MERAH**
NB. * = pilih satu jawaban

VI. *TIPE INSIDEN*

No.	Tipe Insiden		Subtipe Insiden
1.	Administrasi Klinik	a. Proses	1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (*Transfer of care*) 8. Identifikasi pasien 9. *Consent* 10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan
		b. Masalah	1. Tidak *performed* ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pelayanan
2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining/ pencegahan/ *medical check up* 2. Diagnosis/ *assessment* 3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. *General care/ management* 5. Tes/ investigasi 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (*detention/ restraint*)
		b. Masalah	1. Tidak *performance* ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. *Chart*/ rekam medik/ *assessment*/ konsultasi 3. *Checklist* 4. Form/ sertifikat 5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ *Guideline* 6. Label/ stiker/ identifikasi *bands*/ kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ *images*
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen 3. Salah dokumen/ salah orang 4. Tidak jelas/ membingungkan/ *illegible*
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	1. Bakteri 2. Virus 3. Jamur 4. Parasit

			5. Protozoa 6. Rickettsia 7. Prion/ partikel protein yang infeksius 8. Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	1. *Bloodstream* 2. Bagian yang dioperasi 3. Abses 4. Pneumonia 5. Kanul IV 6. Protesis infeksi 7. Drain/ tube urin 8. Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	1. Daftar Medikasi 2. Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Ciaran infus	1. Peresepan 2. Persiapan/ *dispensing* 3. Pemaketan 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. *Supply*/ pesan 7. Penyimpanan 8. Monitoring
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah obat
			1. Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi 2. Salah formulasi/ presentasi 3. Salah rute pemberian 4. Salah jumlah/ kuantitas 5. Salah *Dispensing* Label/ instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. *Ommited medicine or dose* 9. Obat kadaluarsa 10. Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Produk selular 2. Faktor pembekuan (*clothing*) 3. Albumin/ plasma protein 4. Imunoglobulin
		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Tes pre transfusi 2. Peresepan 3. Persiapan/ *dispensing* 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. Penyimpanan 7. Monitoring 8. Presentasi/ pemaketan 9. *Supply*/ pesan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah darah/ produk darah 3. Salah dosis/ frekuensi 4. Salah jumlah 5. Salah label *dispensing*/ Instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. Obat atau dosis yang diabaikan 9. Darah kadaluarsa 10. Efek samping/ *adverse effect*
7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	1. Nutrisi umum 2. Nutrisi khusus

		b. Proses nutrisi	9. Peresepan/ permintaan 10. Pesiapan/ manufaktur/ memasak 11. *Supply/* pesan 12. Penyajian 13. *Dispensing/* alokasi 14. Pengantaran 15. Pemberian 16. Penyimpanan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah diet 3. Salah jumlah 4. Salah frekuensi 5. Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait
		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	1. Label silinder/ warna kode/ *index pin* 2. Peresepan 3. Pemberian 4. Pengantaran 5. Supply/ order
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah gas 3. Salah *rate/ flow/* konsentrasi 4. Salah mode pengantaran 5. Kontraindikasi 6. Salah penyimpanan 7. Gagal pemberian 8. Kontaminasi
9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ *Equipment property*	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ *Equipment property*	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ *equipment property*
		b. Masalah	1. Presentasi/ pemaketan tidak baik 2. Ketidaktersediaan 3. *Inapropiate for task* 4. Tidak bersih/ tidak steril 5. Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien	1. Tidak kooperatif 2. Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar 3. Berisiko/ sembrono/ berbahaya 4. Masalah dengan penggunaan substansi/ *abuse* 5. Menggangu/ *harrassment* 6. Diskriminasitif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederai diri, bunuh diri.
		b. Agresi / *Assault*	1. Agresi verbal 2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh	1. Tersandung 2. Slip 3. Kolaps 4. Hilang keseimbangan
		b. Keterlibatan saat jatuh	1. *Velbed* 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet 6. Peralatan terapi 7. Tangga

			8. Dibawa/dibantu oleh orang lain
12.	Kecelakaan	a.Benturan tumpul	1. Kontak dengan benda/binatang 2. Kontak dengan orang 3. Hancur, remuk
		b. Serangan tajam/ tusukan	Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan
		c. Kejadian mekanik lain	1. Benturan akibat ledakan bom 2. Kontak dengan mesin
		d. Peristiwa mekanik lain	
		e. Mekanisme Panas	Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan
		f. Ancaman pada pernafasan	Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ *confinement to oxygen-deficient place*
		g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya	1. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 2. Bahan kimia korosif
		h. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera	1. Paparan listrik/radiasi 2. Paparan suara/ getaran 3. Paparan tekanan udara 4. Paparan karena gravitasi rendah
		i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	1. Daftar struktur 2. Daftar bangunan 3. Daftar *furniture* 4. Inadekuat 5. Damaged/ faulty/ worn
14.	*Resource*/ Manajemen organisasi	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan Sumber Daya Manusia Ketersediaan/ keadekuatan staf Organisasi/ Tim b. *Protocols*/ Kebijakan/ SOP Guideline c. Ketersediaan/ *Adequacy*	
15	Laboratorium/ Patologi	Pengambilan/ *pick up transport sorting* data *entry* proses verifikasi/ validasi hasil	

4. Penyebab langsung (Direct / Proximate / Immediate Cause)
Tidak melakukan double check saat penyiapan obat (pengambilan obat dan pemasangan etiket obat), serta dalam proses penyerahan ke pasien.

5. Akar penyebab masalah (underlying - root cause)

Ketidaktelitian petugas farmasi dalam penyiapan dan penyerahan obat karena obat Ketoprofen dan ketokonazole terletak berjarak satu obat dengan fisik yang terlihat berbeda.

6. Rekomendasi / Solusi

NO	AKAR MASALAH	REKOMENDASI/ SOLUSI
1	Ketidak telitian petugas	Melakukan pengecekkan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check) Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE
2		

NB.* : Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain
Saran : Baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselaman Pasien